Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

UE n°7
Sciences Humaines et Sociales

Marie-France Mamzer
PU-PH Ethique médicale et Médecine Légale

Année universitaire 2026-27

Université Paris Cité

Ethique en santé: Principes, courants, pratiques

Marie-France Mamzer

INTRODUCTION

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE L'ÉTHIQUE ET LA MORALE?

Des nuances complexes et controversées

- La racine du mot « éthique » est d'origine grecque (éthos), celle du mot « morale » est latine (mos, moris).
  - Les deux termes renvoient à l'idée de mœurs (habitudes, coutumes, usages)
  - Certains considèrent que les deux mots ont le même sens (cf dictionnaire Larousse)
    - Ethique: qui concerne la morale
    - Morale: qui concerne les règles de conduite pratiquées dans une société, en particulier par rapport aux concepts de bien et de mal
- La philosophie morale est une branche de la philosophie qui cherchent à répondre à la question « que dois-je faire? » et « pourquoi? »

La morale

- L'apport de la sociologie d'Emile Durkheim (fin XIX-début XXème)
  - [La morale est une discipline théorique (« spéculation méthodique et systématique sur les choses de la morale ») qui permet aux penseurs de fonder leurs jugements moraux sur des principes. Les penseurs cherchent et énoncent des raisons à leurs jugements qui dépendent de leur manière de voir l'homme]
  - **La morale est un fait empiriquement observable**
    - C'est un « **ensemble de jugements que les hommes, individuellement ou collectivement, portent sur leurs propres actes comme sur ceux de leurs semblables »**. Selon Durkheim, ces jugements sont spontanés, et inconscients et permettent de faire la différence entre les actes moraux et les actes immoraux
- La morale est de l'ordre du devoir : Pour faire le bien, il faut suivre les règles du vivre ensemble qui se sont établies dans la société. Ces règles associent souvent des interdits et des obligations

=> La morale n'a pas de portée universelle

L'éthique est un questionnement

- **Questionnement sur nos actes**
  - Questionnement sur
    - Ce qu'il convient de faire lorsqu'il n'existe pas de solution évidente
    - Comment le faire, sous quelles conditions
  - Questionnement à une double échelle (individuelle et collective)
    - Situations complexes
    - Contexte d'incertitude
    - ➢Plusieurs choix possibles
- **Quelle décision prendre dans une situation donnée, et sur quels fondements ?**
  - Fondement déontologique (appliquer la règle)
  - Fondement téléologique (dans le but de répondre à une finalité)

L'éthique est une visée

- **Réflexion préalable à une action responsable**
  - **Notion de responsabilité du sujet ou des institutions**
  - ➢ Nécessité de répondre de ses actes
  - ➢ Nécessité d'expliciter les choix et le mécanisme des choix, en référence à des valeurs et/ou des principes
- **L'objectif est de faire le meilleur (ou le moins mauvais) choix dans une situation particulière, en référence à des valeurs, des principes, des règles**
  - ➢ **Pose la question de ce qui est bien, juste ou le moins mal**
  - ➢ **Pose la question de qui définit le bien et comment**
    - Hétéronomie vs autonomie

L’éthique n’est pas une norme

- **Les normes imposent aux acteurs des limites de l’extérieur**
  - Les normes peuvent être de différentes natures:
    - Norme naturelle
    - Norme sociale
    - Norme morale
    - Norme juridique
  - Les normes définissent les contours, l’état des lieux de ce qui s’impose, est accepté
- **L’éthique est une « visée » pour le ou les « acteurs »**
  - Implique une réflexion sur les possibles, préalablement à un choix
  - Permet parfois de proposer des repères en vue de l’évolution des normes

Ethique et professionnels de santé

- **Questionnement dans le contexte du progrès scientifique et de ses applications sur les êtres vivants** (biotechnologies)
  - Dimensions individuelles
  - Dimension collective
- **Questionnement pratique, sur les limites, les normes**
  - Nécessité d'agir, dans un contexte précis
- **Dans ce sens, l'éthique n'est pas un « label » qui permet de caractériser un type d'action particulièrement « morale »**
  - Deux situations en apparence semblables mais qui diffèrent sur un point particulier, en apparence minime, peuvent aboutir à deux décisions différentes
  - La décision prise doit être argumentée et contextualisée +++

Le questionnement éthique en santé, en résumé

- Les avancées des sciences, les nouvelles technologies biomédicales et l'évolution des courants de pensée de la société génèrent de nouvelles questions morales
- **En situation concrète, il peut s'agir de dilemmes, ou de tensions** qui ne peuvent pas toujours être résolues par les normes traditionnelles
- **La visée éthique** nécessite une réflexion en vue d'une « action humaine responsable »,
- **Le questionnement éthique cherche à définir ce qu'il est souhaitable de faire parmi tout ce qui peut être fait, dans des cas concrets, complexes et en situation d'incertitude.**
- **Chaque décision prise au terme de ce questionnement doit être argumentée**

L'éthique en santé est un questionnement concret et contextualisé

- Faut-il le faire (et pourquoi)?
- Comment, dans quelles conditions le faire, ou ne pas le faire (et pourquoi?)?

DES MODÈLES THÉORIQUES POUR PENSER L'ÉTHIQUE

« En général, l'action des hommes vise le « bien », mais comment définir le bien? »

Les champs de l'éthique

- Les champs de la philosophie morale
  - La méta-éthique: pas de visée normative
    - Etude des concepts, des jugements et des raisonnements moraux.
  - L'éthique normative:
    - Propose des « normes », qui prescrivent le « bien » et/ou le « mal »
- Les éthiques appliquées:
  - Questions spécifiques posées aux éthiques normatives par des domaines particuliers, dont l'éthique médicale, la bioéthique, la neuroéthique, etc…

Les principales théories morales sous tendant les modèles théoriques de l'éthique normative

Ruwen Ogien, Christine Tappolet (2009)
Jean-Cassien Billier (2010)

- **Une théorie morale est une construction intellectuelle abstraite** qui vise à proposer un cadre réflexif, composé d'un ou plusieurs principes qui permettent de déterminer si une action particulière est moralement juste.
- **Ces théories morales qui sous-tendent l'éthique normative sont regroupées en trois familles:**
  - Les éthiques de la vertu
  - Les éthiques déontologiques
  - Les éthiques conséquentialistes

Les éthiques de la vertu (en très bref)

Ruwen Ogien, Christine Tappolet (2009)
Jean-Cassien Billier (2010)

- **L'action qu'il faut accomplir est celle qu'aurait accompli un être humain en tant qu'agent moral vertueux dans ces circonstances**
  - Concept central : vertu
  - ➢ Ce qui compte c'est le perfectionnement de l'être humain en tant qu'agent moral vertueux
  - ➢ La question morale principale n'est pas « que dois-je faire? » mais « quel genre de personne dois-je être? » ou quelles sont les actions que je dois accomplir pour agir vertueusement

- **Exemples de philosophes de l'éthique de la vertu:**
  - Aristote (antiquité)
  - Thomas d'Aquin (XIIIème s)
  - Elisabeth Anscombe, Bernard Williams (XXème s)

Les théories déontologiques (déontologisme)

Ruwen Ogien, Christine Tappolet (2009)

- **Une action est morale si elle est accomplie en suivant des principes absolus qui doivent être appliqués quelles qu'en soient les conséquences**
  - Concept central: le devoir
  - ➢ Méthodes de pensée qui s'intéressent à la façon selon laquelle les actes humains peuvent être faits conformément à des règles
  - ➢ Il existe des principes moraux qui doivent être des règles d'action
  - ➢ Certaines actions sont strictement requises (exigences), d'autres sont strictement prohibées (interdictions)
- **Exemples de philosophes penseurs des théories déontologiques :**
  - Emmanuel Kant (XVIII-XIXème s)
  - William David Ross (XIX-XXème s)

Les théories conséquentialistes (1)

Ruwen Ogien, Christine Tappolet (2009)

- **L'action « morale » est celle qui promeut le bien**
  - **Le moteur de l'action est la visée** (du bien ou du moins mal): théorie téléologique
    - Problème de la définition du bien
    - La valeur des conséquences ne dépend pas du point de vue (impartialité)
    - Les valeurs promues sont généralement impersonnelles ou neutres par rapport à l'agent
  - **Méthodes qui s'intéressent aux conséquences** de nos actes (et de nos règles)
    - L'action qu'il faut accomplir est celle dont les conséquences sont les meilleures
    - idée de « maximisation » du bien (ou utilité)

- **Précisions/ nuances:**
  - Il faut inclure dans les « conséquences », l'ensemble des résultats (même indirects)
  - Il est classique de faire une distinction entre l'utilité moyenne et l'utilité totale (prise en compte des individus/personnes *a minima*)
  - Il existe des versions non maximalistes qui visent à une action « suffisamment » bonne (principe de satisfaction)
  - Il existe aussi des versions négatives qui visent à minimisation le mal

Les théories conséquentialistes (2)

Ruwen Ogien, Christine Tappolet (2009)

- **Exemples de théories utilitaristes**
  - Utilitarisme « classique » de Bentham et Mill (XIXème s)
    - Viser le plus grand plaisir (ou le plus grand bonheur) pour le plus grand nombre
    - Maximiser les plaisirs et minimiser les douleurs
  - Exemples de versions plus récentes
    - Viser la satisfaction des préférences ou celle des intérêts
    - Incorporation de valeurs relatives à l'agent

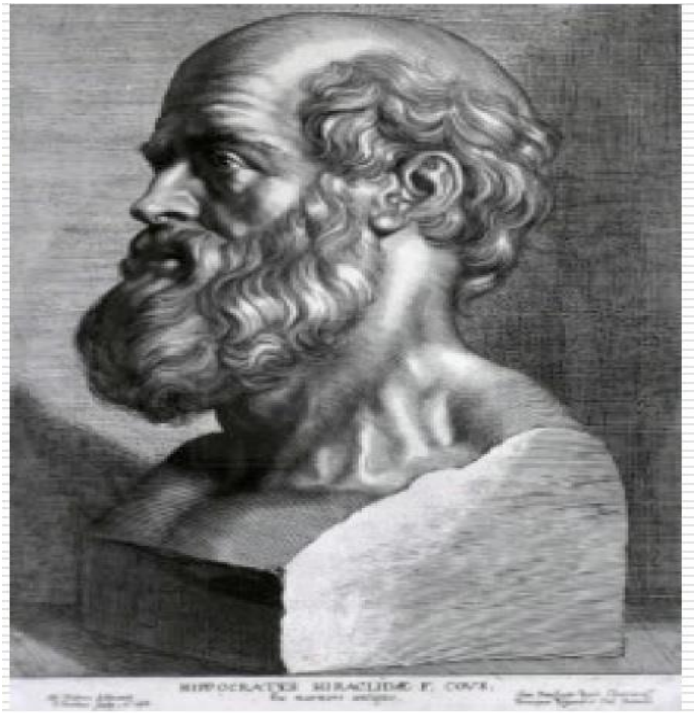
UNE ÉVOLUTION PROGRESSIVE DES DÉTERMINANTS DES DÉCISIONS MÉDICALES

Une évolution des connaissances

Une transition de la morale médicale Hippocratique vers l'éthique en santé

Hippocrate

- -460 avant JC dans l'Ile de Cos
- Famille des Asclépiades, médecins de père en fils
- « Père » symbolique de la médecine (fondateur d'une école)
- Médecin itinérant en Grèce
- Mort à plus de 85 ans



Médecine hippocratique (1)

- **Médecine « publique »**
  - Médecin nommé par l'assemblée du peuple, payé par la cité
  - Pas de préoccupation de santé publique
- **Approche globale du malade**
  - Corps, esprit, comportement, environnement
- **Médecine des faits et de l'observation**, en rupture avec la médecine religieuse et magique
- **Médecine d'école**: corpus de plus de 60 ouvrages, probablement plusieurs auteurs (déontologie, diététique, sémiologie, étiologie, chirurgie, gynécologie, thérapeutique…)

Médecine hippocratique (2)

- **Le corps humain** est divisé en parties solides et liquides (les humeurs)
- **Il existe 4 humeurs**: le sang, la bile noire, la bile jaune, le phlegme
- **La santé est** définie par l'équilibre de ces humeurs et des relations harmonieuses entre le corps et son environnement (la nature)
- La nature est composée de 4 éléments: l'air, l'eau, le feu et la terre

Médecine hippocratique (3)

- **La maladie est** un événement naturel due à une instabilité des composants du corps et à la perturbation des rapports entre l'homme et son milieu
- **Les symptômes sont** l'expression de la lutte du corps pour le rétablissement de la santé
- La médecine c'est « l'adjonction de ce qui manque et le retrait de ce qui redonde »
- Hippocrate s'intéresse beaucoup plus au malade qu'à la maladie

La morale médicale à l'ère d'Hippocrate

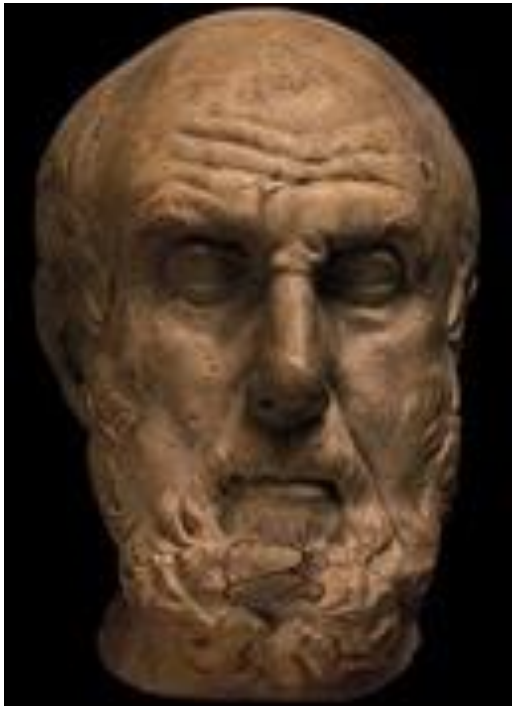
- **Le médecin doit veiller avant tout à l'intérêt du malade**, quel que soit son statut social ou financier
  - Médecin dans l'abnégation et le dévouement
  - Pas de recherche de gloire personnelle
  - Pas de recherche d'enrichissement
- Pas de préoccupation sociale

Les premières règles déontologiques de la profession médicale

- **Le médecin a des devoirs multiples** :
  - Il ne peut et ne doit pas abuser de sa situation
  - Il a un devoir de discrétion
  - Le soin et la propreté apportés à sa tenue favorisent l'installation d'une bonne relation avec le patient
  - Il doit se préoccuper du confort et du bien-être du patient et limiter ses souffrances
- **au nom de valeurs** :
  - Utilité pour le patient
  - Respect de la vie sous toutes ses formes

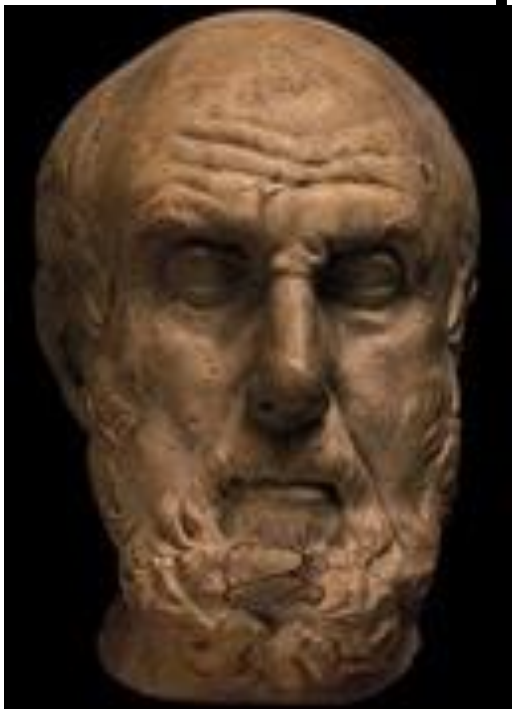
Primum non nocere

(non malfaisance)



- En lien avec l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité corporelle et avec le respect du secret
- Un des principes de la médecine hippocratique au même titre que le principe de bienfaisance
- Inscrit dans les codes de déontologie médicale
- Principe régulateur de l'action médicale
  - Soubassement du principe de précaution et des dérives « risque zéro »

Principe de bienfaisance



- Un des principes de la médecine hippocratique
- Inscrit dans les codes de déontologie médicale
- **Principe directeur de l'action médicale** et de la **relation médecin patient**
  - Soubassement des « dérives paternalistes »

Les premiers codes de déontologies français modernes induisaient une relation paternaliste

- **Le fondement de la relation est la confiance, attribuée au médecin en raison de**
- **- son savoir médical qui va permettre de sauver la vie**
- **- son engagement de loyauté, garantie par la déontologie**

- **En vertu du principe de bienfaisance et du devoir d'assistance** à l'égard de celui qui est en situation de vulnérabilité (maladie, ignorance), le médecin « soulage » le patient de la décision, qu'il est seul qualifié à prendre du fait de son savoir
- Le patient se confie au soignant comme l'enfant à ses parents
- Ce qui justifie l'acte la finalité thérapeutique

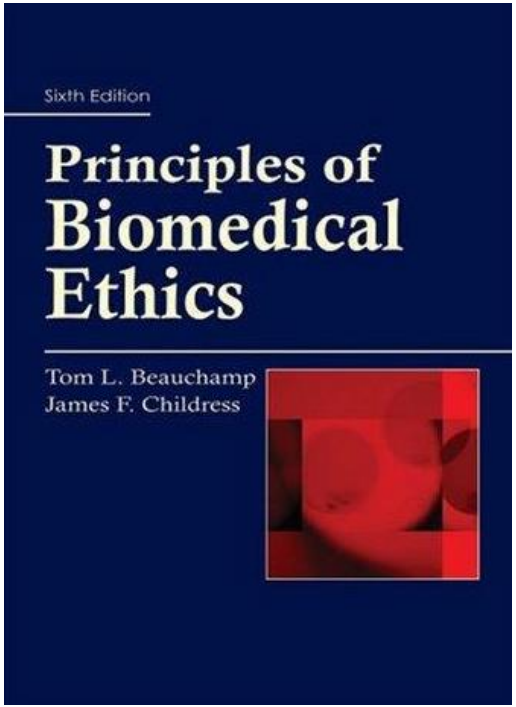
LE MOUVEMENT BIOÉTHIQUE ET LA NAISSANCE DE L'ÉTHIQUE MÉDICALE

De la morale médicale Hippocratique à la réflexion éthique en médecine

Le mouvement bioéthique

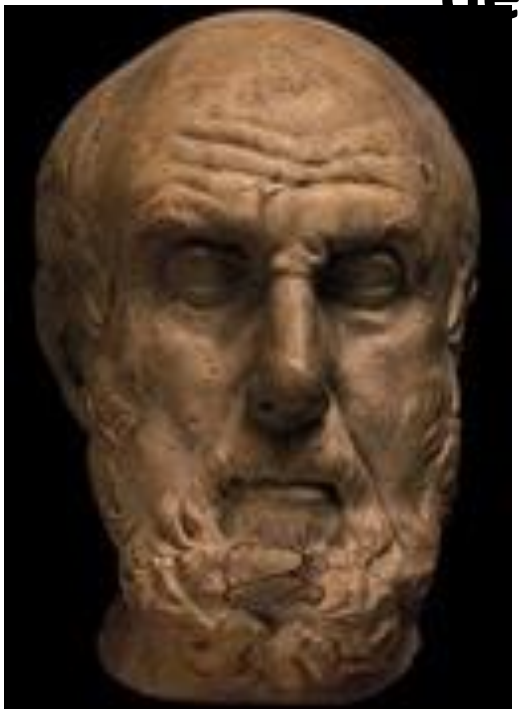
- **Un mouvement de contestation sociale dirigé contre le corporatisme**
- **Origine nord-américaine, visée régulatrice**, s'inscrit dans la sphère de l'éthique normative, générale et appliquée
  - Issu d'un décalage entre les attentes des patients et celle de la société (santé individuelle et santé publique)
    - Mobilisation des associations de patients
    - Médecine plus « juste » (précise et équitable)
    - Médecine plus respectueuse de la dignité humaine (place de l'autonomie)
- **Dans la droite ligne de l'éthique de la recherche et dont les premiers principes régulateurs sont issus du** rapport Belmont (1977-78) et de ses trois principes incontournables :
  - **Respect de la personne, bienfaisance, et justice.**
- **Fondement du « principisme »**, développé ensuite en 1979 par Beauchamp et Childress

Le Principisme (principlisme)



- **Quatre principes cardinaux qui obligent**
  - **Autonomie**
  - **Non malfaisance**
  - **Bienfaisance**
  - **Justice-Equité**
- **Des éthiciens, et des consultations d'éthique clinique**
  - L'analyse éthique des situations cherche une harmonisation entre les principes ou démontre pourquoi l'obligation morale générée par l'un d'entre eux est prédominante

Une évolution de la compréhension du principe de bienfaisance



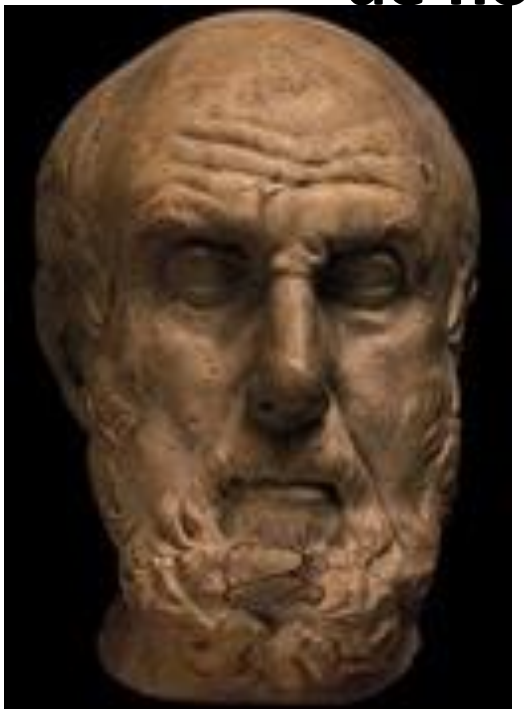
S'agissant d'un principe d'action…

… Il implique une réflexion sur son sens en situation concrète

- **Sauver la vie**
- Prolonger la vie
- Guérir
- **Soulager la douleur**
- **Améliorer le confort**
- **Surmonter le handicap**

- **Conseiller, prévenir la maladie**
- **Ecouter, être présent**

Une évolution de la compréhension du principe de non malfaisance

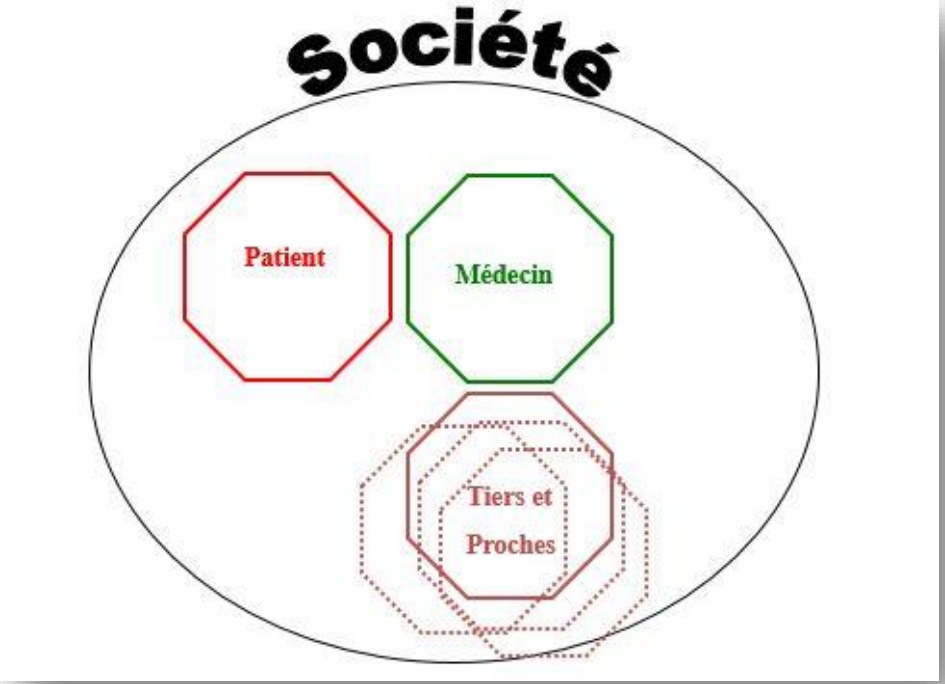


… Il implique une réflexion sur son sens en situation contextuelle

- **En « intention de traiter »: Balance bénéfice/risque**
- **Situations d'urgence, maladies chroniques, prévention**
  - Sauver la vie, **pour qu(o)i?**
  - Prolonger la vie, **dans quelles conditions?**
  - Soulager la douleur, **jusqu'où**
- **Analyse a posteriori: aléa thérapeutique**

S'agissant d'un principe de limitation de l'action…

Une évolution du modèle de relation médecin-malade devient plus complexe et justifie des normes externes spécifiques : des repères et des Lois qui vont au-delà des simples règles déontologiques



Les valeurs phares actuelles de la norme en médecine (1):
la dignité humaine

- Principe fondamental de la bioéthique française (Lois de bioéthique de 1994):

« ***La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie*** » (Art. 16 du code civil)

- Principe protecteur des individus et de l'humanité
- Principe de limitation de la liberté individuelle qui interdit aux individus certains usages de leur propre corps

Les valeurs phares actuelles de la norme en médecine (3):

l'Autonomie

- La reconnaissance de l'autonomie comme valeur phare (principe du respect de l'autonomie), le modèle paternaliste devient caduque
- Autonomie matérialisée par un consentement éclairé exigible (loi du 4 mars 2002)

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix … »

- La valeur (validité) du consentement dépend de trois conditions:
  - La loyauté de l'information
  - La compétence décisionnelle de celui qui consent
  - Sa liberté de choisir

Les manquements de l'autonomie

- **Les fragilités**
  - pour Emmanuel Levinas ou Hans Jonas, le principe de bienfaisance fonde la moralité sur la fragilité de l'autre.
- **Le principe de responsabilité de Hans Jonas:**
  - **Devoir moral à l'égard du plus fragile et du plus menacé.**
  - **Absence de réciprocité**

COMMENT PRENDRE UNE DÉCISION EN PRATIQUE DANS UN CAS COMPLEXE ET EN SITUATION D'INCERTITUDE ?

QU’EST-CE QU’UNE DÉCISION?

Définitions

d'après le Larousse en ligne

- **Décision**, nom féminin.
  - Action de **décider après délibération**; acte par lequel une autorité prend parti après examen
  - Acte par lequel quelqu'un opte pour une solution, décide quelque chose: résolution, choix

- **Délibération**, nom féminin
  - Action de réfléchir, d'examiner une question; discussion
  - Décision prise au cours de cet examen
  - Littéraire. Examen réfléchi précédant une décision
  - Concertation obligatoire avant toute décision que doit rendre une juridiction de jugement

(Une) définition philosophique (1)

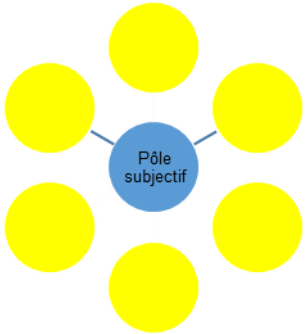
- **Vocabulaire technique et critique de la philosophie (André Lalande, 1926)**
  - **Sens 1: La décision est la « Terminaison normale de la délibération dans un acte volontaire », « choix réfléchi de l'un des actes possibles »**
    - Simple conclusion logique, ou conclusion faisant intervenir quelque chose de plus
    - S'oppose aux terminaisons anormales (délibérations inachevées ou interrompues, choix « idéologiques », sans délibération)

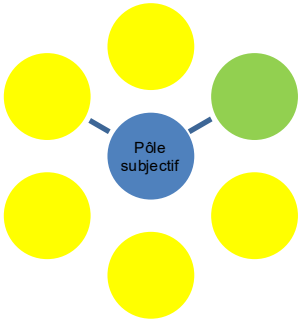
(Une) définition philosophique (2)

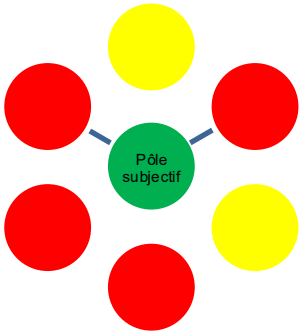
Daniel Parrochia (2009). Philosophie et épistémologie de la décision

- La décision est un concept qui implique:
  - Un pôle subjectif (sujet engagé dans une action)
  - Une situation objective (contexte présentant une certaine indétermination et dans lequel s'inscrit cette action)

Les conséquences de la décision





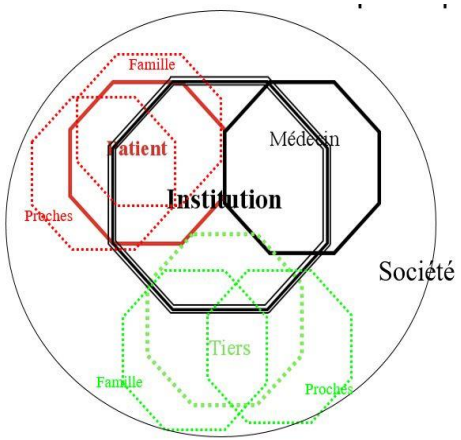


LES PRINCIPAUX DES DÉTERMINANTS DE LA DÉCISION MÉDICALE ET LEUR ÉVOLUTION

Les composantes « objectives » de la situation dans laquelle la décision médicale est prise

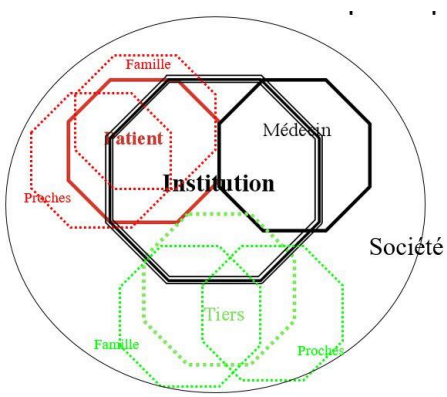
Les contraintes de la situation :

- L'état de santé du patient
- La compétence du médecin
- Les limites des connaissances médicales (l'état de l'Art et les situations d'incertitude)
- Le cadre légal et réglementaire
- Les moyens disponibles



Les « pôles de subjectivité » de la décision médicale

- **Le malade**
- Les proches
- **Le médecin**
- Les tiers (associations de patients, autres sources d'expertise « profane »)
- **La société**
  - Le cadre légal et réglementaire
  - Les moyens financiers



A chaque niveau : une place pour les émotions, les désirs, les peurs, les doutes, les préférences et les valeurs morales